

Symptom-Screening im MII PRO-Modul 2026.4.0

MIDOS2 (Palliativmedizin) & PRO-CTCAE Onkologisches Basisscreening (DKG) — Architektur, Mapping, Quellverifikation

TL;DR. Zwei neue Symptom-Screening-Instrumente, dieselbe Symptomliste in unterschiedlicher Granularität. MIDOS2 (13 Items, DGP-4-stufig) für Palliativmedizin, PRO-CTCAE Onkologisches Basisscreening (23 Items aus 10 AEs, NCI-5-stufig) für Onkologie. PRO-CTCAE Complete (124 Items) als experimentelle Master-Itembank, von der das Basisscreening per `derivedFrom` ableitet. Item-Wordings gegen NCI-Originaldokumente (EN/DE) verifiziert.

ARCHITEKTUR

Resource	Items	Status	Rolle
PRO-CTCAE Complete (Master)	124	experimental, kein Package	Kanonische Itembank · <code>derivedFrom-Target</code>
PRO-CTCAE Onkologisches Basisscreening	23 (10 AEs)	active, im Package	Allgemein-onkologisches Screening · DKG-Kontext
PRO-CTCAE Breast-DE	21	active, im Package	Brustkrebs-Subset · Refactoring auf <code>derivedFrom</code> nötig
MIDOS2	13	active, im Package	Eigenständig · Palliativmedizin · DGP-Skala

Warum Master-Q statt nur CodeSystem? Eine Itembank braucht Antwortskalen, `ordinalValue-Extensions`, `Conditional Logic`, `Rendering-Hinweise` — alles, was ein `CodeSystem` nicht trägt. `Questionnaire.derivedFrom` ist die korrekte FHIR-Semantik für Variant-Beziehungen. Das `CodeSystem` bleibt als semantisches Registry für `Observation.code` und Mappings.

MIDOS2 ↔ PRO-CTCAE SYMPTOM-MAPPING

#	MIDOS2 Symptom	PRO-CTCAE AE	Attribute	Items (OB)	Hinweis
1	Schmerz	#48 General Pain	<code>frq+sev+int</code>	3	1:1
2	Übelkeit	#9 Nausea	<code>frq+sev</code>	2	1:1
3	Erbrechen	#10 Vomiting	<code>frq+sev</code>	2	1:1
4	Luftnot	#19 Shortness of Breath	<code>sev+int</code>	2	1:1
5	Verstopfung	#15 Constipation	<code>sev</code>	1	1:1
6	Müdigkeit + Schwäche	#53 Fatigue	<code>sev+int</code>	2	PRO-CTCAE bündelt
7	Appetitmangel	#8 Decreased Appetite	<code>sev+int</code>	2	1:1
8	Depressivität	#55 Discouraged + #56 Sad	<code>je frq+sev+int</code>	6	PRO-CTCAE zerlegt
9	Angst + Anspannung	#54 Anxiety	<code>frq+sev+int</code>	3	PRO-CTCAE bündelt
10	Wohlbefinden gesamt	— (kein Äquivalent)	—	0	nur in MIDOS2
Summe Onkologisches Basisscreening:				23	10 AEs

KONFLIKTPUNKTE ZUR KLÄRUNG

- Schwäche vs. Müdigkeit:** MIDOS2 trennt, PRO-CTCAE bündelt zu Fatigue (#53). Vorschlag: in MIDOS2 beide Items behalten, im Basisscreening als ein Symptom.
- Anspannung vs. Angst:** Analog Fatigue. MIDOS2 trennt, PRO-CTCAE bündelt zu Anxiety (#54).
- Depressivität:** PRO-CTCAE zerlegt bewusst in #55 Mutlosigkeit (Discouraged) und #56 Traurigkeit (Sad). MIDOS2-Depressivität soll daher auf *beide* AEs mappen (= 6 Items für ein MIDOS-Symptom).
- Wohlbefinden gesamt:** Nur in MIDOS2 vorhanden, kein PRO-CTCAE-Äquivalent. Onkologisches Basisscreening lässt es weg.

QUELLVERIFIKATION GEGEN NCI-ORIGINALDOKUMENTE

Methode: PRO-CTCAE Item Library v1.0 (EN), deutsche Übersetzung (NCI-autorisiert) und Quick Guide (Version 5/12/2025) direkt vom NCI bezogen. Vergleich pro AE (Symptom-Term, Attribute, EN- und DE-Fragetext) gegen die aktuelle FSH-Implementierung. **Status:** 10 AEs für MIDOS-Mapping geprüft, Vollabgleich aller 78 AEs ausstehend.

Beispiel-Match: AE #9 Nausea / Übelkeit ✓

NCI-Original	MI I FSH
"Wie HÄUFIG hatten Sie ÜBELKEIT?"	<code>proctcae-09a-frq</code> · identisch
"Wie STARK war Ihre ÜBELKEIT im SCHLIMMSTEN FALL?"	<code>proctcae-09b-sev</code> · identisch

Diskrepanzen ⚠

AE	NCI	FSH (falsch)
#27 Hair Loss	A (Amount)	<code>int only</code>
#59 Vaginal Discharge	A (Amount)	<code>int only</code>

→ Amount-Skala fehlt im CodeSystem. Aufwand: 1 ValueSet + 2 Item-Korrekturen. Vermutlich weitere Funde bei Vollabgleich.

MIDOS2 — ÜBERSICHT

Items (13 gesamt)

- 11 Symptom-Items · 4-stufige DGP-Skala (keine/leichte/mittlere/starke)
- 1 Wohlbefinden-Item · 4-stufig (sehr gut/eher gut/eher schlecht/sehr schlecht)
- 1 freitext für sonstige Beschwerden

Score

Symptom-Summen-Score = Summe der 11 Symptom-Items ∈ [0, 33]. Höhere Werte = stärkere Symptomlast. Wohlbefinden separat (nicht im Sum-Score). Quelle: Stiel et al. 2010/2012 — *Item-Wordings zu verifizieren* (Bead 5jd).

STAKEHOLDER-ENTSCHEIDUNGSBEDARF

1	Mapping-Granularität	Schwäche + Anspannung in MIDOS2 zusätzlich behalten?
2	Depressivität	Auf #55 + #56 mappen (6 Items) oder nur #55 Mutlosigkeit?
3	Antwortskalen Basisscreening	Alle PRO-CTCAE-Attribute je AE oder vereinfacht nur Severity?
4	Wohlbefinden	Nur in MIDOS2, nicht im Basisscreening?
5	PRO-CTCAE Korrekturen	AE #27, #59 in 2026.4.0 mit beheben?
6	MIDOS2-Quellverifikation	Wer hat Zugriff auf Stiel et al. 2010/2012?

Status. Branch `feature/v2026.4.0-symptom-screening` · MIDOS2 + Onkologisches Basisscreening gebaut (Q + CS + VS + Beispiel-QR + IG-Doku, SUSHI 0 Errors). Offen: PRO-CTCAE Master Q, Breast-DE-Refactoring, CodeSystem-Korrekturen, MIDOS2 Source-Verifikation, optional Symptom-ObsDefs. | **Quellen.** NCI PRO-CTCAE Item Library v1.0 (healthcaredelivery.cancer.gov/pro-ctcae) · Hamacher et al., BMC Cancer 2023 · Stiel et al., Der Schmerz 2010/2012 · Bruera et al., J Palliat Care 1991 (ESAS).